진정 내시경 후 수면무호흡 평가로 연결

회복 후 상담용 · 검사 중 관찰 소견과 평소 수면 증상을 함께 기록

관찰에서 확진 검사까지

진정 중 관찰 소견
심한 코골이 · 무호흡
갑작스러운 SpO_2 저하

→

회복 후 문진·선별
평소 증상과 동반질환
설문·신체진찰

→

수면 평가 의뢰
정확한 진단에는
수면다원검사(PSG)

관찰 소견과 평소 증상을 분리 기록

내시경 중 관찰	회복 후 문진
☐ 심한 코골이 ☐ 무호흡	평소 ☐ 코골이 ☐ 목격 무호흡/질식감
SpO_2 최저 ___%	☐ 주간졸림 ☐ 비회복성 수면·피로/불면
소견·상황·시각 _____	기존 OSA 진단·치료 _____

정유삼 연자 Q&A · 진정 내시경 질문

의심 단서는 수면 평가로 이어집니다

심한 코골이·중간 무호흡 또는 갑작스러운 **SpO_2 <90%**를 보인 환자에 대해, 연자는 평소 수면무호흡 가능성이 높다고 답했습니다. 설문·신체진찰로 선별하고 **정확한 진단에는 PSG가 필요**하다고 설명했습니다.

SpO_2 <90%는 질문에 제시된 관찰 상황입니다. 이 소견 하나를 OSA 확진으로 기록하지 않습니다.

평소 증상·동반질환과 의뢰 인계

☐ 주간졸림·피로·불면, 목격된 숨 멎음·질식감 확인

☐ 고혈압·2형 당뇨·뇌졸중·기분/인지장애·관상동맥질환·심부전·심방세동 확인

☐ 수면 평가 기관/예약 _____ 담당 _____
전달 소견 _____ 결과 확인일 _____

환자에게 설명할 연결 문장

"검사 중 코골이·숨 멎음이 관찰됐습니다. 평소 수면에서도 이런 증상이 있는지 살펴보고, 수면검사로 정확히 평가하겠습니다."

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560

회복 후 선별 · 수면검사

상세 · 연자 Q&A의 선별 항목과 강의의 객관적 평가

정유삼 연자 Q&A의 STOP-Bang

항목	체크할 내용
S · T · O · P	Snoring · Tiredness · Obstruction · Hypertension
B · A	**BMI >35** · **Age >50**
N · G	목둘레: 남성 **>43 cm** · 여성 **>41 cm** 남성 성별

연자의 Q&A 선별 설명

8항목 중 **3~4점**은 중간위험, **5점 이상**은 고위험으로 설명했습니다. 위 목둘레와 점수는 연자 Q&A에 제시된 값입니다. 선별 뒤 정확한 진단은 PSG로 연결합니다.

강의의 진단 설명: 증상 + 객관적 지수

연자가 설명한 경로	진단 평가
증상 또는 동반질환이 있음	AHI/RDI **5 이상**
증상·동반질환이 없어도	AHI/RDI **15 이상**

AHI: 시간당 무호흡+저호흡 수. RDI: 무호흡+저호흡+호흡노력 관련 각성(RERA) 수. SpO_2 저하 지수(ODI)는 다른 지표입니다.

PSG로 확인하는 것

호흡 흐름과 호흡 노력을 함께 봅니다

폐쇄성 무호흡은 기류가 멎어도 흉부·복부 움직임이 유지되고, 중추성은 기류와 움직임이 함께 멎는 패턴으로 설명했습니다. 성인 무호흡은 **10초 이상**, 소아는 **2호흡 주기 이상** 기준을 제시했습니다. PSG는 해부학적 평가를 대신하지 않습니다.

검사 후에도 치료·추적을 이어갑니다

선별 도구와 치료의 연결

스마트워치·휴대용 장비는 선별에 도움이 되지만, 확인과 치료 연결에서는 PSG를 강조했습니다. 주된 치료는 양압기이며 수술·구강장치·체중 관리를 함께 고려합니다. 재발이 의심되면 추적 수면검사를 포함한 재평가가 필요합니다.

강의 신체진찰에서는 기립 자세의 윤상갑상막 수준 목둘레와 OSA의 연관성을 설명하고 40 cm를 언급했습니다. Q&A의 선별 점수 목둘레와 구분해 기록합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/sedation-suspected-osa-referral-card/